

08

BLOQUES TEMÁTICOS

03

GASTROENTEROLOGÍA

Esófago y estómago, intestino y colon, hígado e hipertensión portal, vía biliar y páncreas.
Texto oficial de estudio, 100 % adaptado al Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh y a las Garantías Explícitas en Salud (GES).

3

CLASES GRANULARES DE ALTA
DENSIDAD

9

RECONSTRUCCIONES OFICIALES
FECHADAS

GES

NORMAS TÉCNICAS MINSAL VIGENTES

Índice general

01	Esófago y Estómago	3
	1.1. Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett	5
02	Intestino y Colon	8
	2.1. Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable	10
03	Vía biliar y Páncreas	13
	3.1. Pancreatitis Aguda	15
	Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM	18

01

BLOQUE TEMÁTICO

1 clase

ESÓFAGO Y ESTÓMAGO

Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett.

1

CLASE DEL BLOQUE

3

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

GES

NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

PÁGINA

1.1 Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett

5

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

1 CÓDIGO

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.06.1.027	Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 01 · ESÓFAGO Y ESTÓMAGO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
3 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

Pirosis + regurgitación típicas, sin alarma y < 50 años: diagnóstico clínico y prueba con IBP; no se endoscopia de entrada.

El IBP se toma en ayunas, 30–60 min antes de comer. Los antagonistas H₂ están obsoletos y no se combinan con IBP.

Signos de alarma (disfagia, baja de peso, anemia, hemorragia, síntomas nocturnos, > 50 años, > 5 años de pirosis) obligan a endoscopia.

Barrett = biopsia con metaplasia intestinal. Lo que decide la cirugía es la displasia, no la metaplasia — son conceptos distintos.

No se erradica *H. pylori* por ERGE; sí es obligatorio erradicarlo en úlcera péptica y linfoma MALT.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

1 DE 1 TEMA

Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y
Esófago de Barrett

EUNACOM 2013 · #12

EUNACOM 2015 · #124

EUNACOM 2019 · #88

1.1. Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El esfínter esofágico inferior no es una válvula anatómica sino un tono muscular mantenido que se relaja de forma transitoria decenas de veces al día. El reflujo se vuelve patológico cuando esas relajaciones son demasiado frecuentes o el aclaramiento esofágico falla: por eso el tratamiento es funcional (suprimir ácido, mejorar el vaciamiento) y la cirugía queda reservada para la excepción.

1. DEFINICIÓN Y PRESENTACIÓN CLÍNICA

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es el paso retrógrado del contenido gástrico al esófago con síntomas o lesión de la mucosa. Su mecanismo es la **relajación transitoria del esfínter esofágico inferior**, no una obstrucción.

Presentación típica: pirosis retroesternal y regurgitación ácida, que empeoran al acostarse y con la ingesta abundante. **Presentación atípica:** tos crónica, asma de difícil control, disfonía, erosiones dentales y dolor torácico no cardíaco.

2. DIAGNÓSTICO: CUÁNDO BASTA LA CLÍNICA Y CUÁNDO SE ENDOSCOPIA

En un paciente menor de 40–50 años con pirosis y regurgitación **típicas y sin signos de alarma**, el diagnóstico es clínico y se inicia prueba terapéutica con inhibidor de la bomba de protones (IBP) por 4 a 8 semanas: la respuesta confirma el diagnóstico.

La **pH-metría esofágica de 24 horas** es el patrón de referencia y se reserva para la duda diagnóstica, la clínica atípica o la evaluación prequirúrgica.

Endoscopia digestiva alta obligatoria si hay signos de alarma: disfagia, odinofagia, baja de peso, anemia o hemorragia, síntomas que despiertan al

paciente, inicio después de los 50 años o pirosis de más de 5 años de evolución (riesgo de esófago de Barrett).

3. TRATAMIENTO

Medidas generales: fraccionar la alimentación, elevar la cabecera de la cama, bajar de peso, suspender tabaco y evitar alcohol, cafeína, comidas grasas y relajantes musculares antes de dormir.

Farmacoterapia: el IBP (omeprazol, esomeprazol, lansoprazol) es el fármaco de elección y debe tomarse **en ayunas, 30–60 minutos antes del desayuno**. Los antagonistas H₂ (ranitidina, famotidina) están desplazados y no deben combinarse con IBP.

Cirugía antirreflujo (funduplicatura de Nissen): paciente joven con ERGE grave dependiente de IBP, hernia hiatal voluminosa sintomática, o esófago de Barrett con displasia de alto grado.

4. ESÓFAGO DE BARRETT

Es la **metaplasia intestinal** del epitelio esofágico (reemplazo del epitelio plano por cilíndrico) secundaria a la exposición ácida crónica. Es asintomático; los síntomas son los del RGE de base.

Su importancia es el riesgo de progresión a **adenocarcinoma de esófago**. La conducta la define la biopsia: metaplasia sin displasia → IBP y endoscopia de vigilancia; displasia de bajo grado → ablación endoscópica; **displasia de alto grado → resección endoscópica o esofagectomía**.

TABLA 1.1 · ERGE — DECISIONES CLAVE QUE SE PREGUNTAN EN EL EUNACOM

1.06.1.027

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Pirosis típica, < 50 años, sin alarma	Prueba con IBP 4–8 semanas	Pedir endoscopia de entrada
Pirosis + disfagia o baja de peso	Endoscopia digestiva alta	Subir la dosis de IBP sin estudiar
Duda diagnóstica / clínica atípica	pH-metría de 24 h	Tratar empíricamente de forma indefinida
Barrett con metaplasia sin displasia	IBP + vigilancia endoscópica	Indicar cirugía por el hallazgo de metaplasia
Barrett con displasia de alto grado	Resección endoscópica / esofagectomía	Solo aumentar IBP y controlar

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

1.1

Mujer de 44 años consulta por pirosis retroesternal y regurgitación ácida de 2 años de evolución, que empeora al acostarse. Ha usado antiácidos ocasionales con alivio parcial. No refiere disfagia, baja de peso ni anemia. Examen físico normal.

Conducta oficial. ERGE no complicada en una paciente menor de 50 años sin signos de alarma: la conducta es prueba terapéutica con IBP en ayunas por 4 a 8 semanas junto con medidas antirreflujo, sin necesidad de endoscopia inicial. La endoscopia se reservaría para falta de respuesta, recurrencia precoz al suspender el IBP o aparición de signos de alarma.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ Pirosis + regurgitación típicas, sin alarma y < 50 años: diagnóstico clínico y prueba con IBP; no se endoscopia de entrada.
- ▶ El IBP se toma en ayunas, 30–60 min antes de comer. Los antagonistas H₂ están obsoletos y no se combinan con IBP.
- ▶ Signos de alarma (disfagia, baja de peso, anemia, hemorragia, síntomas nocturnos, > 50 años, > 5 años de pirosis) obligan a endoscopia.
- ▶ Barrett = biopsia con metaplasia intestinal. Lo que decide la cirugía es la displasia, no la metaplasia — son conceptos distintos.
- ▶ No se erradica *H. pylori* por ERGE; sí es obligatorio erradicarlo en úlcera péptica y linfoma MALT.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 1.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción EUNACOM 2013 · Pregunta #12

1. Hombre de 27 años, sin antecedentes, consulta por 3 meses de dolor epigástrico urente que aumenta con el ayuno y el estrés, con pirosis ocasional. La endoscopia digestiva alta muestra una úlcera duodenal activa y el test de ureasa resulta negativo. No usa AINE. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Iniciar omeprazol, amoxicilina y claritromicina por 14 días
- B) Indicar omeprazol y repetir la endoscopia en 6 semanas
- C) Solicitar una nueva endoscopia con test de ureasa
- D) Iniciar medidas antirreflujo y omeprazol a permanencia
- E) Indicar solo omeprazol por 8 semanas y control clínico

Reconstrucción EUNACOM Julio 2015 · Pregunta #124

2. Paciente con úlcera gástrica y test de ureasa positivo recibe amoxicilina, claritromicina y omeprazol por 10 días, seguido de omeprazol por 4 semanas. El control con test de ureasa a las 6 semanas post-tratamiento sigue positivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Repetir el mismo esquema por 14 días
- B) Realizar endoscopia digestiva alta con biopsias
- C) Indicar terapia erradicadora de segunda línea
- D) Repetir el test de ureasa en 3 meses
- E) Observar la evolución clínica

[Más preguntas online de Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett →](#)

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS
TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO
TEMAS 1.1 A 1.1

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett	Pirosis + regurgitación típicas, sin alarma y < 50 años: diagnóstico clínico y prueba...	El IBP se toma en ayunas, 30–60 min antes de comer. Los antagonistas H₂ están obsoletos...	—

**CIFRAS QUE SE
PREGUNTAN
LITERALMENTE**
60 min

 El IBP se
toma en
ayunas, 30

**REGLAS Y
MNEMOTECNIAS DEL
BLOQUE**

Pirosis + regurgitación típicas, sin alarma y < 50 años: diagnóstico clínico y prueba con IBP; no se endoscopia de entrada.

El IBP se toma en ayunas, 30–60 min antes de comer. Los antagonistas H₂ están obsoletos y no se combinan con IBP.

Signos de alarma (disfagia, baja de peso, anemia, hemorragia, síntomas nocturnos, > 50 años, > 5 años de pirosis) obligan a...

Barrett = biopsia con metaplasia intestinal. Lo que decide la cirugía es la displasia, no la metaplasia — son conceptos...

**COBERTURA
GES DEL
BLOQUE**
GARANTÍAS EXPLÍCITAS APLICABLES

**Sin garantía
GES específica
· Norma
MINSAL de...**

Tema 1.1 ·
Enfermedad por
Reflujo
Gastroesofágico
y Esófago de
Barrett · código
1.06.1.027

**AUTOCHEQUEO FINAL
· SI NO PUEDES
RESPONDER ESTO,
VUELVE AL TEMA
INDICADO**

Pirosis +
regurgitación
típicas, sin
alarma y <
50 años:
diagnóstico
clínico y
prueba con
IBP... → **1.1**

02

BLOQUE TEMÁTICO

1 clase

INTESTINO Y COLON

Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable.

1

CLASE DEL BLOQUE

2

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

GES

NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

PÁGINA

2.1 Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable

10

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

1 CÓDIGO

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.06.1.008	Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 02 · INTESTINO Y COLON

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
2 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

El diagnóstico de SII es clínico y positivo (criterios de Roma IV), no de descarte: no se necesita endoscopia si no hay signos de alarma.

Signos de alarma (ABCDEFH): anemia, baja de peso, cambio del hábito, disfagia, edad > 50 a, familiar con cáncer, hemorragia y síntomas nocturnos.

! TRAMPA · Cualquier signo de alarma obliga a estudio con endoscopia o colonoscopia para descartar cáncer.

Tratamiento: educación + manejo del estrés + dieta baja en FODMAP; amitriptilina si predomina la diarrea, polietilenglicol si predomina la constipación.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

1 DE 1 TEMA

Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome
de Intestino Irritable

EUNACOM 2018 · #41

EUNACOM 2022 · #66

2.1. Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

1. CONCEPTO Y PESO EN EL EXAMEN

Los trastornos digestivos funcionales (TDF) son síntomas digestivos crónicos o recurrentes sin una anomalía estructural o bioquímica que los explique. Son la **primera causa de consulta gastroenterológica** y la principal causa de dolor abdominal crónico, diarrea crónica y constipación crónica.

Hoy se entienden como trastornos del **eje cerebro-intestino**: hipersensibilidad visceral y alteración de la motilidad, gatilladas por estrés, dieta y disbiosis. El síndrome de intestino irritable (SII) es el prototipo.

2. DIAGNÓSTICO DEL SII (CRITERIOS DE ROMA IV)

Dolor abdominal recurrente al menos 1 día por semana en los últimos 3 meses, asociado a **2 o más** de: relación con la defecación, cambio en la frecuencia de las deposiciones o cambio en su consistencia.

Es un diagnóstico **clínico y positivo**, no de descarte: si el paciente cumple los criterios y no tiene signos de alarma, no se requiere una batería de exámenes. Sí se solicitan de rutina hemograma, PCR, TSH, anticuerpos de enfermedad celíaca y —en diarrea— calprotectina fecal.

3. SIGNOS DE ALARMA QUE OBLIGAN A ESTUDIO ORGÁNICO

Cualquier signo de alarma cambia la conducta: se abandona la hipótesis funcional y se estudia con **endoscopia digestiva alta o colonoscopia** según la localización del síntoma.

Regla mnemotécnica **ABCDEFH**: **A**nemia, **B**aja de peso, **C**ambio reciente del hábito o del patrón de síntomas, **D**isfagia, **E**dad de inicio > 50 años, **F**amiliar de primer grado con cáncer digestivo, **H**emorragia (rectorragia, melena) y síntomas nocturnos que despiertan al paciente.

4. TRATAMIENTO DEL SII

Base: **educación** (explicar la naturaleza benigna y descartar cáncer explícitamente en la conversación), **manejo del estrés** y ajuste dietético (dieta baja en FODMAP, fibra soluble).

Farmacoterapia dirigida al síntoma predominante: antiespasmódicos (trimebutino, bromuro de pinaverio) para el dolor; **antidepresivos tricíclicos en dosis baja (amitriptilina)** para el SII con predominio de diarrea; laxantes osmóticos (polietilenglicol) para el predominio de constipación.

TABLA 2.1 · FUNCIONAL VS ORGÁNICO — CÓMO SE DISTINGUE EN LA PRÁCTICA

1.06.1.008

RASGO	TRASTORNO FUNCIONAL (SII)	ENFERMEDAD ORGÁNICA
Edad de inicio	Joven (< 50 años)	> 50 años
Síntomas nocturnos	Ausentes (no despiertan)	Presentes
Baja de peso / anemia	Ausentes	Presentes
Relación con la defecación	Característica (alivia o cambia)	Sin relación clara
Exámenes de rutina	Normales	Alterados (VHS, PCR, calprotectina, Hb)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

2.1

Mujer de 32 años consulta por dolor abdominal en hipogastrio de 8 meses de evolución que alivia tras defecar, con períodos alternados de diarrea y constipación. Sin baja de peso, rectorragia ni anemia. Examen físico y hemograma normales.

Conducta oficial. Cumple criterios de Roma IV para síndrome de intestino irritable (dolor recurrente relacionado con la defecación y con cambio en la frecuencia y la forma de las deposiciones) y no presenta signos de alarma. El diagnóstico es clínico y positivo, no requiere endoscopia. El manejo es educación, dieta baja en FODMAP y fármacos según el síntoma predominante.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El diagnóstico de SII es clínico y positivo (criterios de Roma IV), no de descarte: no se necesita endoscopia si no hay signos de alarma.
- Signos de alarma (ABCDEFH): anemia, baja de peso, cambio del hábito, disfagia, edad > 50 a, familiar con cáncer, hemorragia y síntomas nocturnos.
- Cualquier signo de alarma obliga a estudio con endoscopia o colonoscopia para descartar cáncer.
- Tratamiento: educación + manejo del estrés + dieta baja en FODMAP; amitriptilina si predomina la diarrea, polietilenglicol si predomina la constipación.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 2.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta #41

1. Mujer de 48 años consulta por distensión y dolor abdominal de 1 año, alternando diarrea y constipación. En los últimos 2 meses refiere deposiciones más frecuentes, baja de 4 kg de peso no buscada y un episodio de rectorragia. Su madre tuvo cáncer de colon a los 55 años. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Diagnosticar síndrome de intestino irritable e iniciar dieta baja en FODMAP
- B) Solicitar colonoscopia
- C) Indicar antiespasmódicos y control en 3 meses
- D) Solicitar test de sangre oculta en deposiciones y repetir en 1 año
- E) Iniciar amitriptilina en dosis baja

Caso tipo EUNACOM (banco 2022)

2. Hombre de 29 años consulta por dolor abdominal recurrente de 6 meses que alivia al defecar, asociado a deposiciones más blandas cuando aparece el dolor. Sin baja de peso, anemia ni antecedentes familiares. Hemograma, PCR y anticuerpos anti-transglutaminasa normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Colonoscopia para descartar enfermedad inflamatoria intestinal
- B) Diagnóstico de síndrome de intestino irritable e iniciar manejo
- C) Endoscopia digestiva alta con biopsias duodenales
- D) TAC de abdomen y pelvis con contraste
- E) Prueba terapéutica con inhibidor de la bomba de protones

[Más preguntas online de Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable →](#)

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS
TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO
TEMAS 2.1 A 2.1

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable	El diagnóstico de SII es clínico y positivo (criterios de Roma IV), no de descartar: no...	Signos de alarma (ABCDEFH): anemia, baja de peso, cambio del hábito, disfagia, edad >...	Cualquier signo de alarma obliga a estudio con endoscopia o colonoscopia para descartar...

CIFRAS QUE SE PREGUNTAN LITERALMENTE

Sin cifras numéricas destacadas.

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El diagnóstico de SII es clínico y positivo (criterios de Roma IV), no de descartar: no se necesita endoscopia si no hay signos...

Signos de alarma (ABCDEFH): anemia, baja de peso, cambio del hábito, disfagia, edad > 50 a, familiar con cáncer, hemorragia y...

Cualquier signo de alarma obliga a estudio con endoscopia o colonoscopia para descartar cáncer.

Tratamiento: educación + manejo del estrés + dieta baja en FODMAP; amitriptilina si predomina la diarrea, polietilenglicol si...

COBERTURA GES DEL BLOQUE
GARANTÍAS EXPLÍCITAS APLICABLES
Sin garantía GES · manejo completo en...

Tema 2.1 · Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable · código 1.06.1.008

AUTOCHEQUEO FINAL · SI NO PUEDES RESPONDER ESTO, VUELVE AL TEMA INDICADO

El diagnóstico de SII es clínico y positivo (criterios de Roma IV), no de descartar: no se... → 2.1

03

BLOQUE TEMÁTICO

1 clase

VÍA BILIAR Y PÁNCREAS

Pancreatitis Aguda.

1

CLASE DEL BLOQUE

4

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

GES

NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

PÁGINA

3.1 Pancreatitis Aguda

15

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

1 CÓDIGO

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.06.2.010	Pancreatitis Aguda	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 03 · VÍA BILIAR Y PÁNCREAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
4 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

Diagnóstico = 2 de 3: dolor típico + lipasa/amilasa > 3× el límite superior + imagen compatible. Con los dos primeros no se necesita TAC.

La magnitud de la elevación enzimática NO se correlaciona con la gravedad; el hematocrito y el BUN en ascenso a las 24 h sí predicen necrosis.

Pilar del tratamiento: reposición de volumen precoz y agresiva con Ringer lactato, ajustada a diuresis. Es lo que más reduce la mortalidad.

Realimentación oral precoz (24–72 h) apenas cede el dolor, incluso en pancreatitis grave. Se evita la nutrición parenteral.

NO antibióticos profilácticos en pancreatitis no infectada. CPRE urgente (< 24 h) solo si hay colangitis asociada.

Pancreatitis biliar leve: colecistectomía en el mismo ingreso para prevenir la recurrencia.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

1 DE 1 TEMA

Pancreatitis Aguda

EUNACOM 2013 · #66

EUNACOM 2013 · #121

EUNACOM 2016 · #54

EUNACOM 2019 · #101

3.1. Pancreatitis Aguda

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La pancreatitis aguda es autodigestión: la activación intraacinar prematura del tripsinógeno desencadena una cascada de enzimas que digieren el propio páncreas y el retroperitoneo. Eso explica el dolor transfixiante, el íleo, la pérdida masiva de líquido al tercer espacio y por qué el pilar del tratamiento en las primeras 24 horas es la reposición agresiva de volumen — el paciente está perdiendo litros hacia el retroperitoneo aunque su piel esté seca.

1. DIAGNÓSTICO: 2 DE 3 CRITERIOS

El diagnóstico de pancreatitis aguda requiere **2 de los siguientes 3** (criterios de Atlanta revisada 2012): (1) dolor abdominal compatible —epigástrico, intenso, transfixiante, irradiado en faja al dorso—; (2) **lipasa o amilasa > 3 veces el límite superior normal**; (3) hallazgos de pancreatitis en imagen (TAC con contraste, ecografía o resonancia).

La **lipasa es más sensible y específica** que la amilasa y permanece elevada más días. La magnitud de la elevación enzimática **no** se correlaciona con la gravedad.

Si el paciente cumple los dos primeros criterios, **no se necesita TAC para el diagnóstico**. La TAC con contraste se indica a las 72 horas si hay duda diagnóstica o si el paciente evoluciona mal (para evaluar necrosis).

2. ETIOLOGÍA: BUSCAR SIEMPRE LA CAUSA

Las dos causas más frecuentes en Chile son la **litiasis biliar** (cálculo que obstruye la ampolla de Vater; más frecuente en mujeres, con elevación de transaminasas y de fosfatasa alcalinas) y el **alcohol** (varón, consumo intenso y sostenido).

Otras: hipertrigliceridemia (> 1000 mg/dL), post-CPRE, fármacos, hipercalcemia, autoinmune, trauma y tumores. A todo paciente se le solicita **ecografía abdominal** en las primeras 24–48 h para buscar coledolitiasis y perfil lipídico y calcemia.

3. ESTRATIFICACIÓN DE GRAVEDAD

La clasificación de Atlanta revisada define pancreatitis **leve** (sin falla orgánica ni complicaciones locales), **moderadamente grave** (falla orgánica transitoria < 48 h o complicación local) y **grave** (falla orgánica persistente > 48 h).

Scores predictivos: **BISAP** (BUN > 25, alteración de conciencia, SIRS, edad > 60, derrame pleural) es el más simple; APACHE-II el más usado en UCI; los criterios de Ranson requieren 48 h. Un **hematocrito elevado y en ascenso, o un BUN que sube** a las 24 h, predicen necrosis y mala evolución.

4. MANEJO INICIAL (PRIMERAS 24–48 HORAS)

Reposición de volumen agresiva y precoz: cristaloides, de preferencia **Ringer lactato**, 5–10 mL/kg/h ajustando por diuresis (meta > 0,5 mL/kg/h), frecuencia cardíaca y hematocrito. Es la intervención que más impacta en la mortalidad.

Analgesia potente (opioides; la meperidina ya no se prefiere). **Régimen cero** inicial, con **realimentación oral precoz** (dentro de 24–72 h) apenas cede el dolor y el íleo, incluso en pancreatitis grave (nutrición enteral por sonda nasoyeyunal si no tolera vía oral). La nutrición parenteral se evita.

NO se indican antibióticos profilácticos en la pancreatitis aguda no infectada, ni siquiera en la necrótica estéril. Los antibióticos se reservan para la necrosis infectada demostrada o la colangitis concomitante.

Pancreatitis biliar: colecistectomía en el mismo ingreso una vez resuelto el episodio leve; **CPRE urgente (< 24 h)** solo si hay colangitis asociada u obstrucción biliar persistente.

TABLA 3.1 · DOLOR EPIGÁSTRICO AGUDO — CÓMO SE SEPARA LA PANCREATITIS DE SUS IMITADORES

1.06.2.010

DIAGNÓSTICO	CLAVE QUE LO DISTINGUE	EXAMEN QUE CONFIRMA
Pancreatitis aguda	Dolor transfixiante al dorso + lipasa > 3× · íleo	Lipasa/amilasa; TAC a las 72 h si evoluciona mal
Coledocolitiasis	Dolor + ictericia, sin fiebre · lipasa normal o poco elevada	Ecografía (colédoco > 7 mm) → colangio-RM
Colangitis aguda	Tríada de Charcot: dolor + ictericia + fiebre	Ecografía + hemocultivos → CPRE
Úlcera perforada	Dolor brusco "en puñalada", abdomen en tabla	Radiografía de tórax de pie: neumoperitoneo
IAM de cara inferior	Factores de riesgo CV, síntomas vagales	ECG de 12 derivaciones + troponina
Isquemia mesentérica	Dolor desproporcionado al examen, FA, acidosis con lactato	Angio-TAC de abdomen

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

3.1

Hombre de 45 años, sin antecedentes, consulta por dolor epigástrico intenso de 12 horas irradiado al dorso, con vómitos biliosos. Al examen: FC 90/min, PA 140/90, escleras levemente ictéricas, abdomen blando y doloroso a la palpación epigástrica sin signos peritoneales. Laboratorio: leucocitos 13.000/mm³, PCR 55 mg/L, lipasa 640 U/L (VN < 60), bilirrubina total 2,8 mg/dL de predominio directo, ecografía con colelitiasis y colédoco de 6 mm.

Conducta oficial. Cumple 2 de 3 criterios de Atlanta (dolor típico + lipasa > 3 veces el límite superior), por lo que el diagnóstico es pancreatitis aguda, de etiología biliar (colelitiasis, patrón colestásico leve). Aunque coexista una probable coledocolitiasis, "manda" la pancreatitis por ser la condición más grave. El manejo inicial es hospitalización, reposición agresiva con Ringer lactato ajustada a diuresis, analgesia, régimen cero con realimentación precoz y ecografía ya realizada; NO se inician antibióticos profilácticos. La CPRE urgente solo se justificaría si apareciera colangitis (fiebre alta, mayor ictericia, compromiso hemodinámico).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ Diagnóstico = 2 de 3: dolor típico + lipasa/amilasa > 3× el límite superior + imagen compatible. Con los dos primeros no se necesita TAC.
- ▶ La magnitud de la elevación enzimática NO se correlaciona con la gravedad; el hematocrito y el BUN en ascenso a las 24 h sí predicen necrosis.
- ▶ Pilar del tratamiento: reposición de volumen precoz y agresiva con Ringer lactato, ajustada a diuresis. Es lo que más reduce la mortalidad.
- ▶ Realimentación oral precoz (24–72 h) apenas cede el dolor, incluso en pancreatitis grave. Se evita la nutrición parenteral.
- ▶ NO antibióticos profilácticos en pancreatitis no infectada. CPRE urgente (< 24 h) solo si hay colangitis asociada.
- ▶ Pancreatitis biliar leve: colecistectomía en el mismo ingreso para prevenir la recurrencia.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 3.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción EUNACOM 2013 · Pregunta #121

1. Hombre de 45 años consulta por dolor epigástrico intenso y vómitos biliosos. Al examen: FC 90/min, PA 140/90, escleras levemente ictéricas, abdomen blando y doloroso a la palpación epigástrica. Exámenes: escleras ictéricas leves, lipasa 190 U/L (VN < 60), bilirrubina total 3,1 mg/dL directa, ecografía con colédoco de 9 mm y microlitiasis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Colangitis aguda
- B) Pancreatitis aguda
- C) Coledocolitiasis
- D) Colecistitis aguda
- E) Cólico biliar simple

Reconstrucción EUNACOM Julio 2016 · Pregunta #54

2. Paciente de 55 años con pancreatitis aguda biliar de 36 horas de evolución. Está hemodinámicamente estable, afebril, con dolor en disminución y tolera líquidos. Ecografía: colelitiasis, vía biliar de calibre normal, sin cálculos en el colédoco. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la vía biliar?

- A) CPRE de urgencia en las próximas 24 horas
- B) Colecistectomía laparoscópica durante el mismo ingreso, una vez resuelto el episodio
- C) Alta con colecistectomía programada en 6 a 8 semanas
- D) Colangiorresonancia y luego CPRE si es positiva
- E) Manejo médico indefinido, sin cirugía, por el riesgo quirúrgico

[Más preguntas online de Pancreatitis Aguda →](#)

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS
TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO
TEMAS 3.1 A 3.1

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Pancreatitis Aguda	Diagnóstico = 2 de 3: dolor típico + lipasa/amilasa > 3× el límite superior + imagen...	La magnitud de la elevación enzimática NO se correlaciona con la gravedad; el...	—

CIFRAS QUE SE PREGUNTAN LITERALMENTE
24 h

La magnitud de la elevación enzimática NO se...

< 24 h

NO antibióticos profilácticos en pancreatitis...

72 h

Realimentación oral precoz (24

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Diagnóstico = 2 de 3:

dolor típico + lipasa/amilasa > 3× el límite superior + imagen compatible. Con los dos primeros no se...

La magnitud de la elevación enzimática NO se correlaciona con la gravedad; el hematocrito y el BUN en ascenso a las 24 h sí...

Pilar del tratamiento: reposición de volumen precoz y agresiva con Ringer lactato, ajustada a diuresis. Es lo que más reduce la...

Realimentación oral precoz (24–72 h) apenas cede el dolor, incluso en pancreatitis grave. Se evita la nutrición parenteral.

COBERTURA GES DEL BLOQUE
GARANTÍAS EXPLÍCITAS APLICABLES
Sin garantía GES específica · manejo...

Tema 3.1 · Pancreatitis Aguda · código 1.06.2.010

AUTOCHEQUEO FINAL · SI NO PUEDES RESPONDER ESTO, VUELVE AL TEMA INDICADO

Diagnóstico = 2 de 3: dolor típico + lipasa/amilasa > 3× el límite superior + imagen... → 3.1

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 1.1 • PREGUNTA 1 Reconstrucción EUNACOM 2013 • Pregunta #12

Hombre de 27 años, sin antecedentes, consulta por 3 meses de dolor epigástrico urente que aumenta con el ayuno y el...

CLAVE A Iniciar omeprazol, amoxicilina y claritromicina por 14 días

Úlcera duodenal activa en un paciente que no usa AINE: se asume infección por *Helicobacter pylori* aunque el test de ureasa sea negativo (falso negativo frecuente si hay sangrado reciente o uso previo de IBP/antibióticos), porque el 90 % de las úlceras duodenales son por *H. pylori*. La conducta es la terapia erradicadora de primera línea (IBP + amoxicilina + claritromicina, 14 días), no solo supresión ácida. B y E tratan la úlcera pero no la causa. D corresponde a manejo de ERGE, no de úlcera.

Perla. C retrasa el tratamiento sin cambiar la conducta.

TEMA 2.1 • PREGUNTA 3 Reconstrucción EUNACOM Diciembre 2018 • Pregunta #41

Mujer de 48 años consulta por distensión y dolor abdominal de 1 año, alternando diarrea y constipación. En los últimos...

CLAVE B Solicitar colonoscopia

Tiene múltiples signos de alarma: edad > 50 (límite), baja de peso involuntaria, cambio reciente del hábito intestinal, rectorragia y antecedente familiar de cáncer de colon. Eso descarta el manejo como trastorno funcional (A, C, E) y obliga a colonoscopia para descartar cáncer colorrectal.

Perla. El test de sangre oculta (D) es una herramienta de tamizaje poblacional en personas asintomáticas, no sirve para estudiar a un paciente sintomático con banderas rojas.

TEMA 3.1 • PREGUNTA 5 Reconstrucción EUNACOM 2013 • Pregunta #121

Hombre de 45 años consulta por dolor epigástrico intenso y vómitos biliosos. Al examen: FC 90/min, PA 140/90, escleras...

CLAVE B Pancreatitis aguda

La lipasa está sobre 3 veces el límite superior (> 180 U/L) junto con dolor típico: cumple criterios de pancreatitis aguda, y aunque coexista una coledocolitiasis (colédoco dilatado, patrón colestásico), "manda" la pancreatitis por ser la condición más grave y la que define la conducta. No hay fiebre ni compromiso hemodinámico que hagan pensar en colangitis (A).

Trampa. El colédoco dilatado y la ictericia descartan un cólico biliar simple (E) y la colecistitis (D) cursaría con Murphy y sin esta magnitud de ictericia.

TEMA 1.1 • PREGUNTA 2 Reconstrucción EUNACOM Julio 2015 • Pregunta #124

Paciente con úlcera gástrica y test de ureasa positivo recibe amoxicilina, claritromicina y omeprazol por 10 días...

CLAVE C Indicar terapia erradicadora de segunda línea

Falla de la erradicación de primera línea confirmada por test de control positivo: se indica un esquema de segunda línea que evite la claritromicina (terapia cuádruple con bismuto, o levofloxacino + amoxicilina + IBP). Repetir el mismo esquema (A) mantiene la resistencia a claritromicina. La endoscopia (B) sería obligatoria para el control de la úlcera gástrica en sí, pero la pregunta apunta a la conducta frente a la falla de erradicación.

Perla. D y E no corrigen la infección persistente.

TEMA 2.1 • PREGUNTA 4 Caso tipo EUNACOM (banco 2022)

Hombre de 29 años consulta por dolor abdominal recurrente de 6 meses que alivia al defecar, asociado a deposiciones más...

CLAVE B Diagnóstico de síndrome de intestino irritable e iniciar manejo

Cumple criterios de Roma IV (dolor recurrente que alivia con la defecación y se asocia a cambio en la consistencia de las deposiciones) sin ningún signo de alarma y con exámenes básicos normales, incluyendo serología celíaca negativa. El diagnóstico de SII es clínico y positivo; corresponde iniciar tratamiento (educación, dieta, fármacos según síntoma) sin más estudios.

Perla. Las alternativas A, C y D son estudios invasivos innecesarios en ausencia de banderas rojas.

TEMA 3.1 • PREGUNTA 6 Reconstrucción EUNACOM Julio 2016 • Pregunta #54

Paciente de 55 años con pancreatitis aguda biliar de 36 horas de evolución. Está hemodinámicamente estable, afebril...

CLAVE B Colecistectomía laparoscópica durante el mismo ingreso, una vez resuelto el episodio

En la pancreatitis biliar leve que ya resolvió, la colecistectomía laparoscópica debe realizarse en el mismo ingreso, porque diferirla se asocia a alta tasa de recurrencia de pancreatitis, colecistitis o colangitis en las semanas siguientes. La CPRE urgente (A) solo se indica si hay colangitis u obstrucción biliar persistente, lo que aquí no ocurre (afebril, vía biliar normal). La colangiografía (D) no aporta porque la probabilidad de coledocolitiasis es baja.

Perla. Diferir la cirugía (C) o no operar (E) deja al paciente expuesto a un nuevo evento.